Les schémas du chapitre 5 à savoir refaire

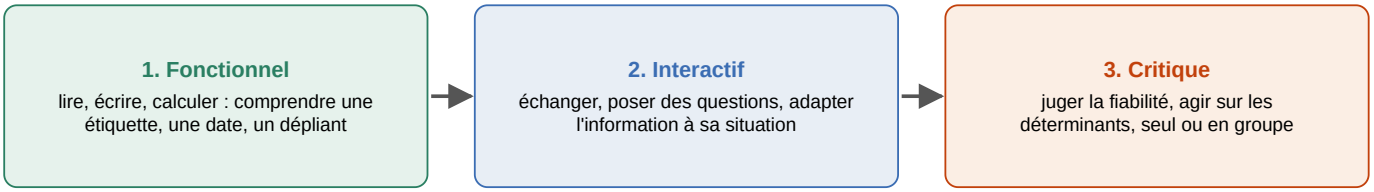
19 schémas qui peuvent tomber à l'écrit (schéma à légender ou à construire) ou être demandés à l'oral E5. Chaque schéma est suivi de ce qu'il faut dire.

1. Les 12 dimensions de la littératie en santé (Sørensen et coll., 2012) (5.3.1, figure 5.1)

	Accéder	Comprendre	Évaluer	Appliquer
Soins (être patient)	trouver un professionnel	comprendre une prescription	juger un conseil reçu	suivre un régime prescrit
Prévention (être à risque)	trouver les repères PNNS	comprendre le Nutri-Score	juger un conseil lu sur un réseau	choisir un produit au magasin
Promotion (être citoyen)	connaître l'offre du quartier	comprendre un projet local	juger une décision publique	agir avec d'autres habitants

Dire : définition de Sørensen : connaissances, motivation et compétences pour accéder, comprendre, évaluer et appliquer l'information, dans les soins, la prévention et la promotion de la santé. 4 × 3 = 12 dimensions, mesurées par les 47 questions du HLS-EU. Le modèle sert de grille de diagnostic et pour écrire des objectifs.

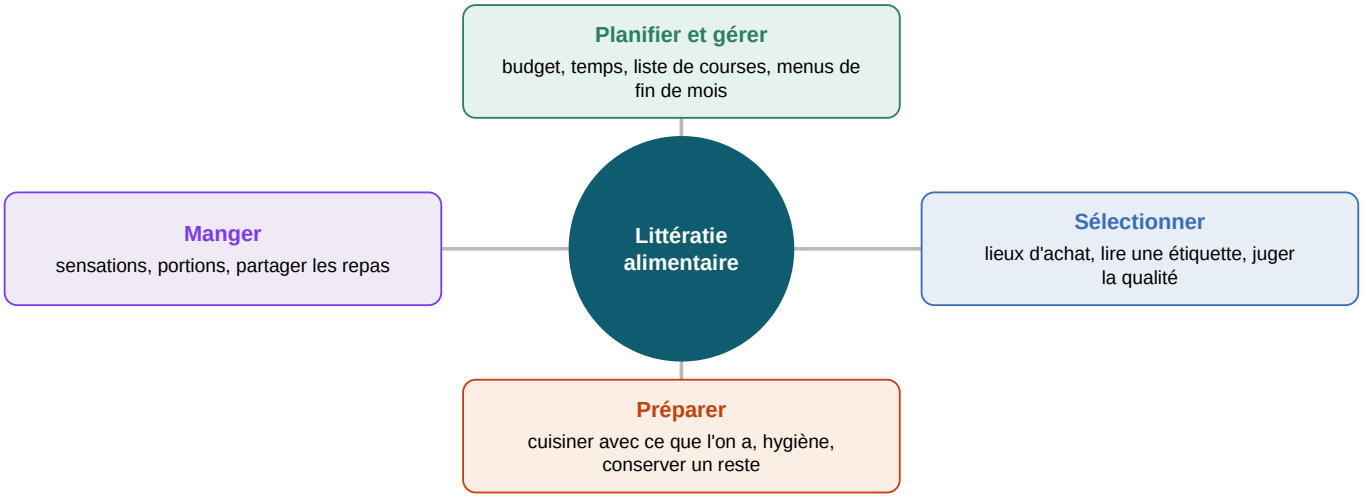
2. Les trois niveaux de littératie en santé (Nutbeam, 2000) (5.3.1, figure 5.2)



plus on monte, plus on gagne en autonomie et en pouvoir d'agir (empowerment) ; la promotion de la santé vise surtout le niveau critique

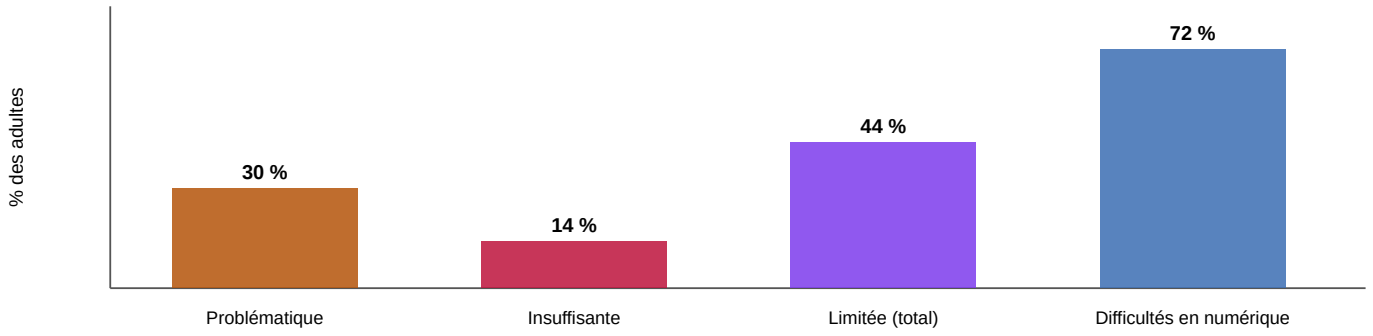
Dire : exemple du niveau critique : un groupe de parents qui obtient une meilleure offre à la cantine, ou des habitants qui obtiennent un marché à prix solidaires. Nutbeam 2008 : la littératie est un facteur de risque à compenser, mais aussi un atout à développer.

3. Les quatre domaines de la littératie alimentaire (Vidgen et Gallegos, 2014) (5.3.1, figure 5.3)



Dire : 4 domaines et 11 composantes, qui sont autant d'objectifs d'atelier évaluables (« sait lire une étiquette », « sait cuisiner les lentilles »). Limite : la littératie alimentaire ne suffit pas quand l'argent, le temps ou l'équipement manquent ; il faut aussi agir sur l'accès.

4. La littératie en santé des adultes en France (HLS19, 2021) (5.3.2, figure 5.4)



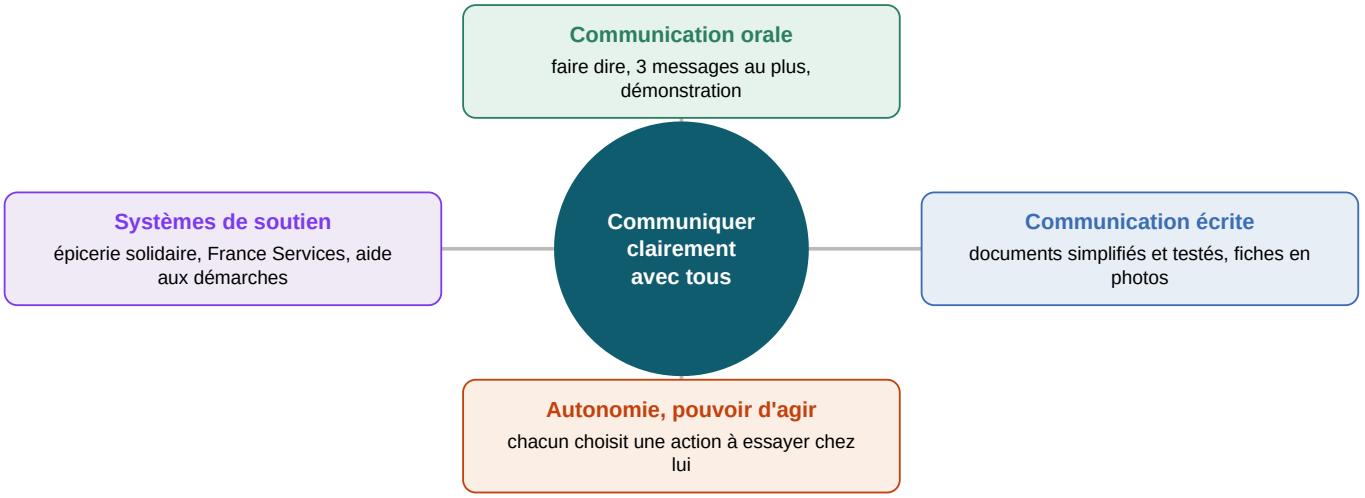
Dire : environ 44 % des adultes ont une littératie limitée (30 % problématique + 14 % insuffisante), 72 % des difficultés avec l'information numérique ; gradient social ; données déclaratives. Ne pas additionner avec l'illettrisme (7 %, 2011) ni l'illectronisme (7 % des 16-74 ans, 2025).

5. Les trois chemins entre littératie et santé (Paasche-Orlow et Wolf, 2007) (5.3.3)

	Ce qui se passe	Exemple	Où agir
Accès	services mal trouvés, démarches abandonnées	la famille ne demande pas le tarif social de la cantine	simplifier, accompagner, aller vers
Relation	moins de questions, moins de compréhension	plan alimentaire non compris, la personne n'ose pas le dire	former les pros, faire dire, donner du temps
Au quotidien	conseils moins bien appliqués	ne sait pas adapter son repas au restaurant	éducation pratique, aliments réels

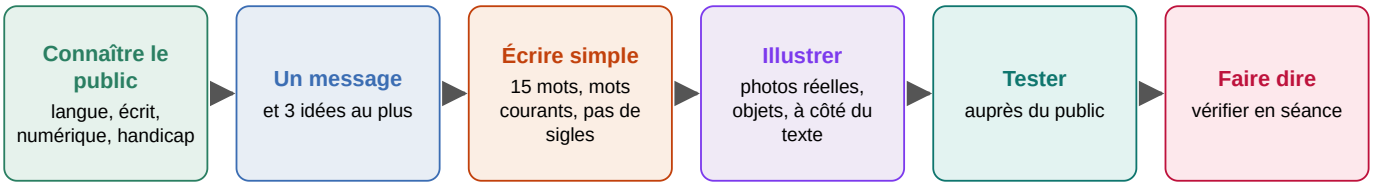
Dire : les professionnels et les organisations sont sur deux chemins sur trois ; un projet efficace agit sur au moins deux. Conséquences d'une littératie limitée (Berkman 2011) : moins de prévention, plus d'hospitalisations, moins bonne gestion des maladies chroniques ; elle creuse les inégalités (universalisme proportionné).

6. Les précautions universelles : la boîte à outils de l'AHRQ (5.3.4)



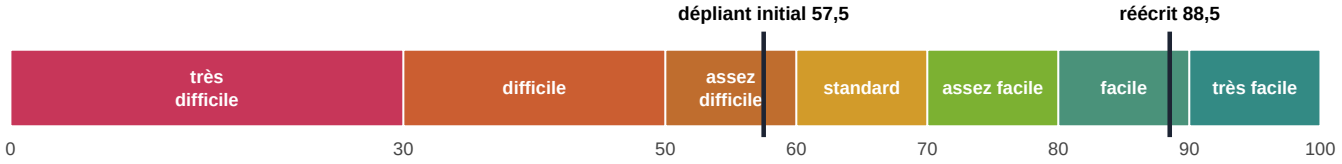
Dire : on ne peut pas savoir en regardant quelqu'un s'il a des difficultés, et elles sont souvent cachées par honte (Parikh 1996 : 4 personnes sur 10). On adapte donc pour tous, sans tester ni désigner. Les tests (REALM, NVS) sont réservés à la recherche et à l'évaluation de programmes.

7. Six étapes pour une communication accessible (5.3.5, figure 5.5)



Dire : règles d'écriture claire (guide « Communiquer pour tous », mis à jour en 2025) : une idée par phrase, forme active et positive, chiffres concrets, police sans empattement de 14, alignée à gauche, gras plutôt qu'italique ou majuscules, contraste fort. Le FALC (Inclusion Europe, 2009) va plus loin et doit être validé par des personnes concernées.

8. L'échelle de lisibilité de Kandel et Moles (1958) (5.3.5, figure 5.5 bis ; fiche O5.2)

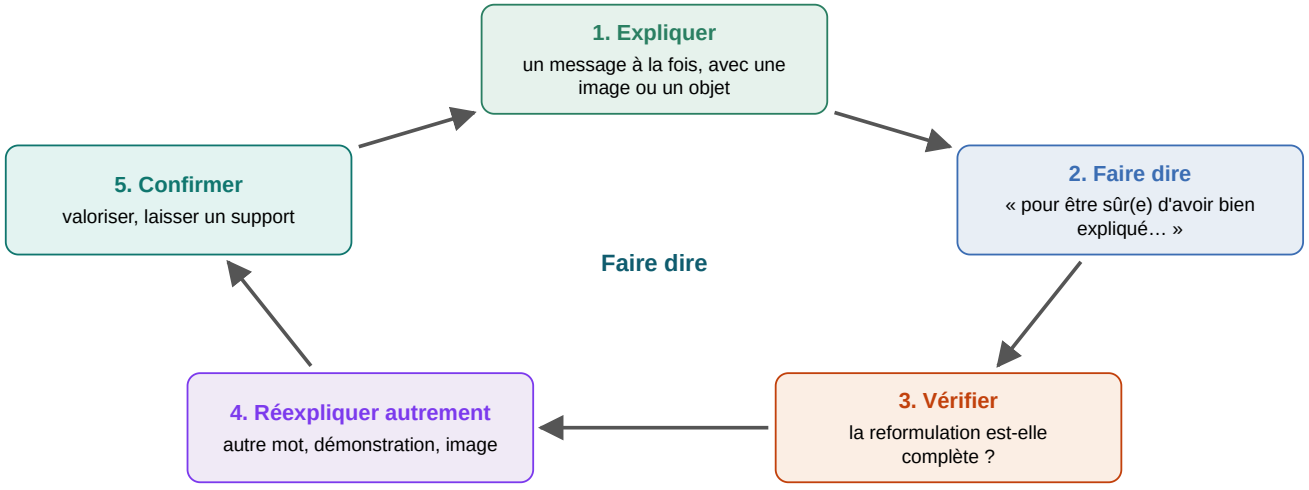


L = 207 − 1,015 × (mots / phrases) − 73,6 × (syllabes / mots)

on vise 80 et plus pour un public à littératie limitée, puis on teste le support

Dire : adaptation française de la formule de Flesch (1948). Plus l'indice est élevé, plus le texte est facile. Les syllabes pèsent lourd : passer de 1,7 à 1,5 syllabe par mot fait gagner 14,7 points. La formule anglaise sous-estime un texte français de 15 à 20 points. L'indice ne mesure ni le sens, ni les images, ni la mise en page.

9. La boucle du « faire dire » (teach-back) (5.3.6, figure 5.6 ; fiche O5.4)



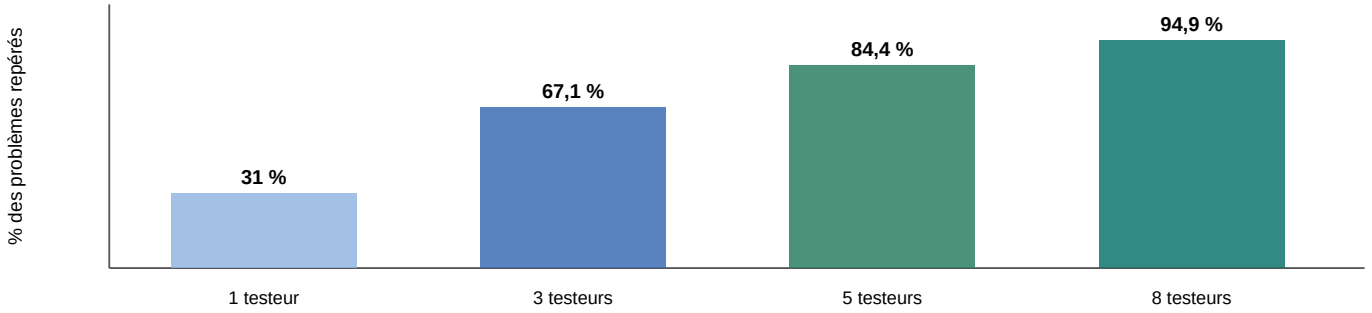
Dire : fiche-outil HAS 2015. On ne demande jamais « Vous avez compris ? » (réponse « oui » par politesse) ; le faire dire teste la clarté du professionnel, pas la mémoire de la personne. Variantes : découper et vérifier, faire faire (gestes, quantités), faire dire au téléphone. Études : meilleure compréhension et autogestion (Ha Dinh 2016).

10. Intégrer la littératie à chaque étape du projet (5.3.7)

1	**Diagnostic**	recueillir langue, lecture, numérique ; questionnaire oral ou imagé, entretiens
2	**Objectifs**	objectifs de compétences vérifiables : « savoir comparer deux céréales avec le Nutri-Score »
3	**Supports**	écriture claire, FALC, pictogrammes ; tester avant de diffuser (5 testeurs ≈ 84 % des problèmes)
4	**Animation**	méthodes actives, démonstration, binômes, faire dire
5	**Communication**	plusieurs canaux ; jamais d'inscription seulement en ligne
6	**Évaluation**	smileys, gommettes, entretien oral ; indicateurs de compréhension

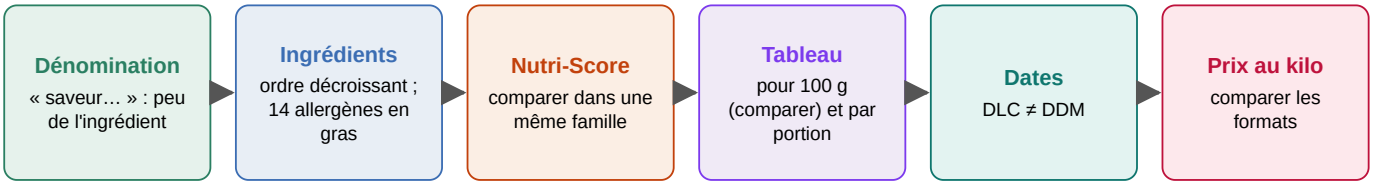
Dire : les verbes d'objectifs suivent la grille de Sørensen : trouver (accéder), expliquer ou montrer (comprendre), comparer (évaluer), préparer (appliquer). « Connaître » et « comprendre » seuls sont trop vagues. Concevoir avec les personnes : relecture, groupe de travail, co-animation.

11. Combien de testeurs pour un support ? (modèle de Nielsen, 2000) (5.3.7)



Dire : part repérée = $1 - (1 - 0{,}31)^n$. Quelques testeurs proches du public repèrent la plupart des problèmes ; mieux vaut deux petits tests successifs (5 personnes, correction, 5 autres) qu'un grand. Le chiffre de 31 % est un ordre de grandeur. Entretien cognitif (Willis 2005) : 5 à 8 personnes, penser à voix haute, tâche pratique.

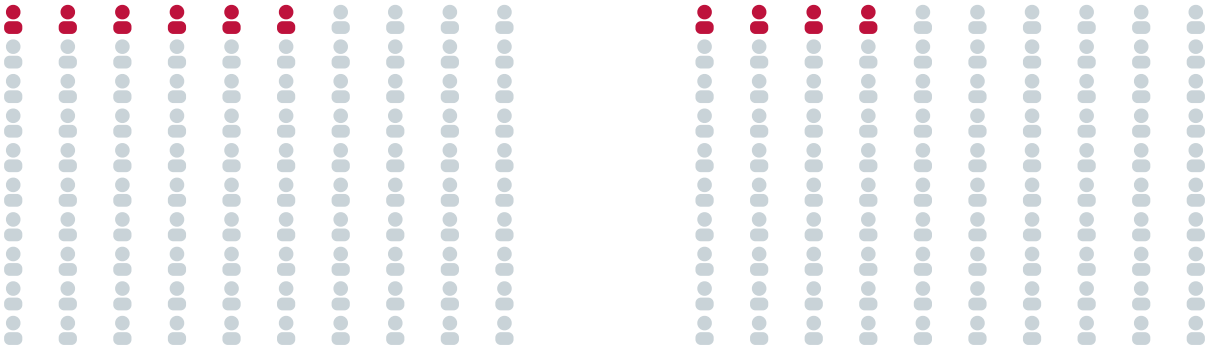
12. Lire une étiquette en six étapes (5.3.8, figure 5.7)



règlement INCO (UE 1169/2011) ; Nutri-Score révisé applicable en France depuis l'arrêté du 14 mars 2025

Dire : traduire les sucres en morceaux : 9,8 g pour 100 mL × 330 mL = 32,3 g ≈ 6,5 morceaux de 5 g, soit 65 % des 50 g de sucres libres conseillés par l'OMS. Allégations (règlement 1924/2006) : « source de fibres » ≥ 3 g/100 g ; « riche » ≥ 6 g ; une allégation ne fait pas un aliment favorable.

13. Un risque présenté en fréquences naturelles avec un tableau d'icônes (5.3.9, figure 5.8)



Sans action : 6 personnes sur 100 — **Avec action : 4 personnes sur 100**

réduction absolue : 2 sur 100 (2 points) · réduction relative : 2 / 6 = 33 % : on donne les deux

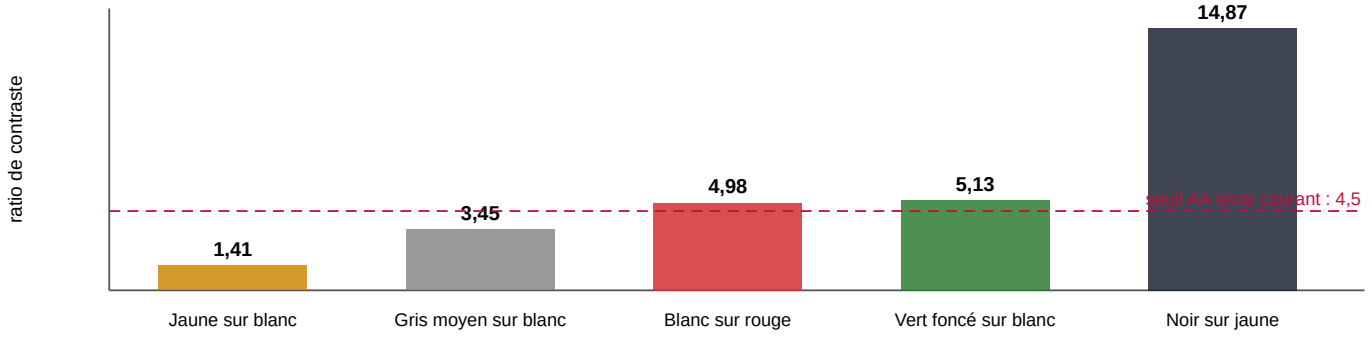
Dire : les fréquences naturelles (« 6 sur 100 ») sont mieux comprises que les pourcentages (Gigerenzer). Présenter seulement « −33 % » exagère l'effet. Pièges : points ≠ pourcentage (25 % → 20 % = 5 points, −20 %), 1 kcal = 4,184 kJ, 33 cL = 330 mL, « jusqu'à », axe de graphique tronqué.

14. Répondre à une idée fausse : le sandwich de vérité (5.3.10)

1	**Le fait juste**	« Les légumes en conserve gardent l'essentiel de leurs fibres et minéraux. »
2	**L'idée fausse, une fois**	« On lit parfois que les conserves sont du poison : c'est faux. »
3	**Pourquoi elle circule**	peur des produits industriels, vidéos qui vendent autre chose
4	**Le fait juste + une action**	« Pratiques et pas chères : rincez-les pour enlever du sel. »

Dire : infodémie (OMS, 2020). Ne pas répéter l'idée fausse dans un titre, ne pas se moquer, partir des questions du groupe. Juger une information en ligne en 6 questions : qui ? informer ou vendre ? quelles sources ? quelle date ? cohérent avec les repères officiels ? promesses miraculeuses ?

15. Rendre un support numérique accessible : contraste et couleur (5.3.10)



Dire : ratio = (luminance claire + 0,05) / (luminance foncée + 0,05), de 1 à 21 ; niveau AA : 4,5 pour un texte courant, 3 pour un grand texte (WCAG, RGAA). Jamais d'information par la couleur seule : 8 % des hommes sont daltoniens ; doubler par un mot ou un pictogramme. Toujours un canal non numérique (France Services, Aidants Connect).

16. Travailler avec un interprète professionnel (5.3.11 ; référentiel HAS 2017)

Avant

- réserver, vérifier la langue
- présenter l'objectif et les mots techniques
- prévoir le double de temps

Au début

- présenter l'interprète et son rôle
- tout sera traduit et confidentiel

Pendant

- regarder la personne, lui parler à la 1re personne
- phrases courtes, pauses
- pas d'expressions imagées
- faire dire

Après

- bilan avec l'interprète
- noter les mots difficiles

Dire : on dit « Qu'est-ce que vous mangez le matin ? » en regardant la personne, et non « Demandez-lui… ». Pas d'enfant interprète. Interprète (traduit, neutre) ≠ médiateur (lien, accès aux droits) ≠ proche (peut filtrer). Une traduction automatique n'est qu'un brouillon : relecture par des locuteurs et test.

17. Médiateur, interprète, habitant relais : qui fait quoi ? (5.4.2 ; exercice 5.40)

	Médiateur en santé	Interprète professionnel	Habitant relais
Rôle	lien entre public et services ; accès aux droits et aux soins	traduire fidèlement, dans les deux sens	informer, mobiliser ses voisins
Cadre	loi de 2016 (L. 1110-13), référentiel HAS 2017	référentiel HAS 2017 ; neutralité, secret	formation courte, bénévole ou indemnisé
Limite	ne remplace pas les professionnels	ne donne pas son avis	pas d'information médicale individuelle

Dire : entretien sur le diabète d'un enfant en bengali → interprète ; faire connaître un atelier dans un immeuble → habitant relais ; familles d'un campement sans droits ouverts → médiateur. Programme national de médiation sanitaire (2011) : meilleure ouverture des droits et vaccination.

18. L'organisation « amie de la littératie » (Brach et coll., 2012) (5.4.3 ; fiche O5.3)

Engagement et organisation

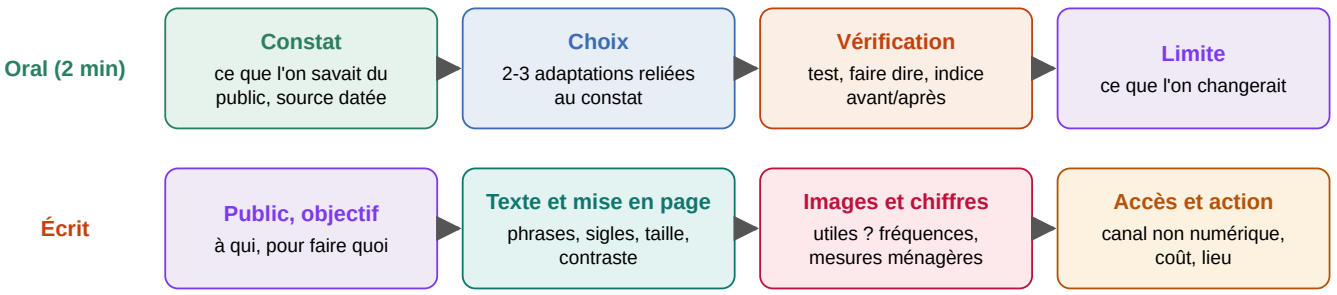
- 1. direction engagée
- 2. littératie dans la planification et l'évaluation
- 3. personnel formé
- 4. public associé aux supports
- 5. niveaux variés sans stigmatiser

Pratiques et supports

- 6. oral clair et vérifié (faire dire)
- 7. orientation facile (signalétique)
- 8. documents faciles à utiliser
- 9. situations à risque (allergènes, dates)
- 10. coûts expliqués clairement

Dire : audit rapide : 0 (absent), 1 (partiel), 2 (en place) par caractéristique, total sur 20, exprimé en pourcentage (11/20 = 55 %), rempli avec l'équipe et des usagers ; priorités sur les 0 faciles à améliorer ; refaire l'audit dans un an. Agir sur la littératie, ce n'est pas seulement former les personnes.

19. À l'épreuve : justifier à l'oral et analyser un support à l'écrit (5.6, méthodes 1 et 2)



Dire : phrases à éviter : « mon public avait un faible niveau », « j'ai testé leur niveau de lecture », « le support était adapté » sans preuve, « j'ai traduit avec Google Traduction ». À l'écrit, pour chaque critère : un constat dans le document, une amélioration précise, puis le test de la nouvelle version.